

WIRKUNGSÖKONOMIE

FÜR MENSCH, PLANET UND DEMOKRATIE

Gesundheit & Pflege

Gesamtdossier mit Beispielen, Datenquellen, Berechnungslogik und Umsetzungspfad

Dokumenttyp	Gesamtdossier
Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Version / Stand	v0.1 · 24. Mai 2026
Status	Arbeitsfassung / Diskussionsfassung

Leitsatz: Gesundheit ist kein medizinisches Ereignis, sondern ein gesellschaftlicher Zustand. Sie entsteht durch Prävention, Resilienz, Stabilität, Teilhabe, Pflege und gutes Leben.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Zweck des Dossiers
- 2. Datenquellen
- 3. Beispielrechnungen
- 4. Tool-Logik
- 5. Akteursperspektiven
- 6. Politische Umsetzung
- 7. Quellen

1. Zweck des Dossiers

Dieses Dossier übersetzt das Konzept Gesundheit & Pflege in Beispiele, Datenquellen, Berechnungslogiken und Umsetzungsoptionen. Es richtet sich an Politik, Verwaltung, Kommunen, Krankenkassen, Pflegeakteure, Unternehmen, Stiftungen, Wissenschaft und Öffentlichkeit.

2. Datenquellen und Vertrauensstufen

Datenquelle	Verwendung
Destatis Gesundheitsausgaben	Makroausgaben, Kostenentwicklung, Trägerstruktur, Gesundheitsausgaben je Einwohner:in.
Destatis Pflegestatistik	Pflegebedürftige, Pflegeformen, stationär/ambulant, Pflegeeinrichtungen.
OECD Health at a Glance	Internationaler Vergleich zu Ausgaben, Prävention, Versorgung, Risikofaktoren.
WHO Social Determinants / One Health	Konzeptionelle Grundlage für nicht-medizinische Gesundheitsdeterminanten und planetare Gesundheit.
RKI / GBE	Indikatoren zu Gesundheit, Krankheit, Prävention, psychischer Gesundheit und Bevölkerungsgesundheit.
Kassen- und Versorgungsdaten	Versorgungspfade, Präventionsprogramme, Krankheitstage, chronische Erkrankungen, Medikations- und Behandlungsdaten – nur aggregiert/datenschutzkonform.
Kommunale Daten	Hitze, Lärm, Grünflächen, Mobilität, Begegnungsräume, Pflegezugang, Sozialstruktur.

3. Beispielrechnungen

Hinweis
Alle Berechnungen sind modellhafte Demonstrationen. Sie ersetzen keine medizinische, gesundheitsökonomische, rechtliche oder haushaltspolitische Prüfung.

Hitzeschutz im Quartier

Investition in Schatten, Wasserpunkte, Grün und Nachbarschaftskommunikation. Vermiedene Wirkung: weniger Notfälle, geringere Belastung vulnerabler Gruppen, weniger Pflege- und Krankenhauslast. Formel: erwartete Risikoreduktion × Basisfälle × Fallkosten + Lebensqualitätsnutzen + Resilienzwert.

- Datenbedarf: Basisrate, Zielgruppe, erwartete Risikoreduktion, Kosten je Ereignis, Zeithorizont, Unsicherheitsband.
- Output: Gesundheitswirkungswert, vermiedene Kosten, Resilienzbeitrag, SDG-/SDG+-Bezug, Datenschutzstatus.

Betriebliche psychische Sicherheit

Investition in Führung, Arbeitszeitgesundheit, Konfliktprävention und Zugang zu Beratung. Vermiedene Wirkung: weniger Burnout, weniger Krankheitstage, geringere Fluktuation, höhere Teamstabilität. Formel: reduzierte Ausfalltage × Kosten pro Ausfalltag + reduzierte Fluktuationskosten + Stabilitätsnutzen.

- Datenbedarf: Basisrate, Zielgruppe, erwartete Risikoreduktion, Kosten je Ereignis, Zeithorizont, Unsicherheitsband.
- Output: Gesundheitswirkungswert, vermiedene Kosten, Resilienzbeitrag, SDG-/SDG+-Bezug, Datenschutzstatus.

Pflegequartier

Kombination aus Tagespflege, ambulanter Versorgung, Angehörigenentlastung, Sturzprävention und digitalem Monitoring. Vermiedene Wirkung: Krankenhausaufenthalte, Heimübergänge, Angehörigenüberlastung, Einsamkeit.

- Datenbedarf: Basisrate, Zielgruppe, erwartete Risikoreduktion, Kosten je Ereignis, Zeithorizont, Unsicherheitsband.
- Output: Gesundheitswirkungswert, vermiedene Kosten, Resilienzbeitrag, SDG-/SDG+-Bezug, Datenschutzstatus.

Schulgesundheits

Bewegung, Ernährung, psychische Stabilität, Schulsozialarbeit und digitale Mobbingprävention. Vermiedene Wirkung: spätere Gesundheitsrisiken, Fehlzeiten, psychische Krisen, Bildungsabbrüche.

- Datenbedarf: Basisrate, Zielgruppe, erwartete Risikoreduktion, Kosten je Ereignis, Zeithorizont, Unsicherheitsband.
- Output: Gesundheitswirkungswert, vermiedene Kosten, Resilienzbeitrag, SDG-/SDG+-Bezug, Datenschutzstatus.

4. Tool-Logik

Die Tool-Suite arbeitet mit modularen Checks. Jedes Modul trennt Eingaben, Annahmen, Datenqualität, Wirkungsbereiche, Unsicherheiten und Ergebnisdarstellung. Es gibt keine Personenscores. Ergebnisse gelten für Programme, Räume, Maßnahmen oder Institutionen.

Tool	Funktion
Gesundheitswirkungsscheck	Bewertet Maßnahmen nach Prävention, Zugang, Teilhabe, Lebensqualität, Resilienz und Nebenwirkungen.
Präventionswirkungsrechner	Schätzt vermiedene Schäden und Kosten durch

	Präventionsmaßnahmen.
Pflegewirkungsscheck	Bewertet Stabilisierung, Würde, Entlastung, Selbstständigkeit, Fachkräftegesundheit.
Kommunaler Gesundheitsraum-Check	Prüft Quartiere nach Hitze, Grün, Bewegung, Versorgung, Begegnung, Sicherheit und Barrierefreiheit.
Mental-Health-Reflexionsmodul	Nicht-diagnostisches Modul für Belastungsräume, Wartezeiten, niedrigschwellige Hilfe und Schutzfaktoren.

5. Akteursperspektiven

- Bürger:innen: Zugang, Würde, Prävention, Datenschutz, keine Schuldlogik.
- Kommunen: Gesundheitsräume, Pflegequartiere, Hitzeschutz, Begegnung, Präventionshaushalt.
- Krankenkassen und Pflegekassen: von Kostenverwaltung zu Gesundheitswirkung.
- Unternehmen: Arbeitsgesundheit, psychische Sicherheit, Produkte und Lieferketten.
- Politik: Rahmen, Finanzierung, Pilotierung, Rechtsschutz, Wirkungsberichte.
- Wissenschaft: Evaluation, Datenqualität, Methoden, Missbrauchsschutz.

6. Politische Anschlussfähigkeit

Ebene	Aufgabe für Politik und Umsetzung
Aufgabe der Politik	Den Rahmen schaffen, damit Gesundheit nicht nur als Behandlungskostenblock erscheint, sondern als präventive, soziale, ökologische und demokratische Systemleistung sichtbar wird.
Politische Rahmenbedingungen	Gesundheitswirkungshaushalte, Präventionsbudgets, Pflegewirkung, kommunale Gesundheitsräume, Datenstandards, Datenschutz, Versorgungssicherheit und unabhängige Evaluation.
Ausgestaltungsspielraum	Parteien können unterschiedliche Wege wählen: stärkere kommunale Steuerung, mehr Kassenautonomie, Präventionsboni, öffentliche Fonds, Versicherungsmodelle, Modellregionen oder gesetzliche Mindeststandards.
Zielkonflikte	Freiheit und Schutz, Prävention und Bevormundungsrisiko, Datenschutz und Frühwarnsysteme, Kostendruck und Qualität, Zentralisierung und Nahversorgung, Innovation und Solidarität müssen demokratisch ausbalanciert werden.
Rollenverteilung	EU, Bund, Länder, Kommunen, Krankenkassen, Pflegekassen, Leistungserbringer, Unternehmen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Bürger:innen tragen unterschiedliche Aufgaben.
Übergang und Schutz	Pilotregionen, Härtefallregeln, Datenschutz, keine Personen-Scores, keine Sanktionierung von Krankheit, Schutz vulnerabler Gruppen, Fachkräfteschutz und digitale Barrierefreiheit.
Evaluation und Korrektur	Wirkungsberichte, Gesundheitswirkungsindex, Präventionswirkungsrechner, Pflegestabilitätsindikatoren, öffentliche Konsultation und Revisionszyklen.
Parteilpolitische Anschlussfähigkeit	Liberale, konservative, sozialdemokratische, grüne, linke, kommunale und wirtschaftsnahe Perspektiven können unterschiedliche Ausgestaltungen wählen, solange Wirkung sichtbar und korrigierbar bleibt.

Quellen und Anschlussdokumente

Diese Arbeitsfassung ist ein öffentliches Fach- und Konzeptsdokument der Wirkungsökonomie. Sie ersetzt keine medizinische, rechtliche oder steuerliche Beratung. Für Diagnosen, Behandlung und individuelle Gesundheitsentscheidungen sind qualifizierte Fachstellen zuständig.

- Weber, Natalie: Die neue Ordnung des Wohlstands. Arbeitsfassung 2026. Kapitel 68 Gesundheit, Kapitel 69 Pflege, Kapitel zu Wirkungshaushalt, Resilienzstaat und Wirkungsfonds.
- Weber, Natalie: Systemmodell der Wirkungsökonomie, 2025. Spalte 7 Gesundheit, Pflege & Leben.
- Weber, Natalie: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.0, 2026.
- World Health Organization (WHO): Constitution of the World Health Organization; Social determinants of health; One Health.
- OECD: Health at a Glance 2025: Germany und Health expenditure on prevention and primary healthcare.
- Destatis: Gesundheitsausgaben 2024; Pflegebedürftige in Deutschland 2023; Gesundheits- und Pflegestatistiken.
- Bundesministerium für Gesundheit: Informationen zu Gesundheit, Prävention, Pflege und Krankenhausstrukturreform.
- Robert Koch-Institut / Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Gesundheitsindikatoren, Prävention, psychische Gesundheit, soziale Determinanten.
- EU / Europäische Kommission: Europäische Gesundheitsdatenräume, EU4Health, Klima- und Gesundheitsbezüge, einschlägige Gesundheits- und Digitalrechtsakte.